ICTERICIA PERSISTENTE: EL DESAFÍO DIAGNÓSTICO DE UNA TRIPLE AGRESIÓN HEPÁTICA

Gabriela Alessandra Niño Rincón- Medico Interno - Hospital Regional de Moniquirá

Presentación del Caso

Motivo de Consulta

"Me puse amarillo"

Enfermedad Actual

Paciente masculino de 43 años de edad, quien ingresa por cursar con un cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en ictericia asociado a prurito y con leve dolor abdominal, niega otros síntomas asociados.

Examen Físico

Signos Vitales: TA: 98/69 FC: 69 FR: 20 SAT: 93% T: 36°C G:15/15

Paciente en aceptables condiciones generales, hidratado, afebril, sin dificultad respiratoria, con tinte ictérico generalizado a nivel de piel y mucosas.

Normocéfalo, escleras ictéricas, conjuntivas normocrómicas, mucosas rosadas y húmedas.

Tórax: simétrico, normoexpansible, sin deformidad, a la auscultación murmullo vesicular conservado, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos sin soplos.

Abdomen: blando, depresible, levemente doloroso a la palpación a nivel de hipocondrio derecho, con murphy positivo, no signos de irritación peritoneal, no masas, ni visceromegalias, ruidos intestinales presentes.

Extremidades: eutróficas, móviles, sin edema, sin lesiones visibles ni palpables, pulsos distales y proximales presentes, simétricos, y de adecuada

intensidad neurológico: alerta, orientado globalmente, glasgow 15/15, lenguaje, juicio y razonamiento aparentemente conservados, memoria retrógrada y anterógrada conservadas, fuerza muscular 4/4, sin alteraciones aparentes de pares craneales, sin signos de focalización.

Antecedentes

-Patológicos: Niega

-Farmacológicos: Niega

-Quirúrgicos: Niega

-Alérgicos: Niega.

Análisis

Paciente masculino de 43 años, quien ingresa por cursar con un cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en ictericia generalizada, prurito y dolor abdominal, en manejo por servicio de cirugía general por un posible síndrome biliar obstructivo en quien se consideró descartar posible coledocolitiasis. Paciente con reporte de colangioresonancia la cual identificó colelitiasis sin colecistitis por ende se procede a realizar colecistectomía laparoscópica. Paciente que durante su estancia hospitalaria fue valorado por el servicio de medicina interna por elevación de bilirrubinas y transaminasas, quienes indicaron estudios de extensión, posterior a esto se cierra interconsulta y se indica control ambulatorio con resultados. Paciente que asiste tras egreso por consulta externa refiriendo persistencia cuadro clínico de 15 días de evolución consistente en ictericia generalizada, cuenta con reporte de estudios complementarios que evidencian citomegalovirus IgG e IgM los cuales resultaron positivo pero este último títulos bajos, adicionalmente con Leptospira IgM inicial y confirmatoria positiva, títulos de ANAS positivo pero con anticuerpos antimitocondriales negativo pero con inmunoglobulina G total elevado se considera cursa con una hepatitis autoinmune agregada a una infección por citomegalovirus y leptospira. Por consiguiente se refirió a urgencias donde se inició el manejo médico y antibiótico idóneo el cual se llevara a 14 días, se espera evolución clínica favorable por el momento se decide hospitalizar, se explica paciente quien refiere entender y aceptar.

Paraclinicos	Imageneologicos
29/12/2025 LIPASA 34.4 TGP 511 TGO 171.8 BT 3.5 BD 2 BI 1.5 AMILASA 57 FOSFATASA 1034.2 HEMOGRAMA L 6590 N 74.2 LINF 16 HB 15 HTO 45.8 PLQ 238MIL PH: 7. 40 PO2:56 mmHg PCO2: 37 mmHg HCO3: 24 mmol/L BE: -0.9 LAC: 0.3 PO2/FIO2: 269 SO2: 89 % // ALCALOSIS METABÓLICA COMPENSADA CON DISFUNCIÓN PULMONAR LEVE CON NORMOLACTATEMIA. **12/01/2026:** BT 6.5, BD 4.5, BI 2.0 ALT 232.2, AST 95.8 **14/01/2026:** BUN 16 CR 0.89 NA 138.9 K 4.19 BT 6.2 BD 4.2 BI 2 HEPATITIS IGM NEGATIVO E IGG POSITIVA - HEPATITIS C NEGATIVO VIH NEGATIVO **17/01/2026:** PT:9.2 PTT:28.6 INR:0.841 BT:7.4 BD:5.2 BI:2.2 ALT:210.5 AST:83.6 **17/01/2026** INR 0.8 PT 9.2/9.2 PTT 28/28 IGG CITOMEGALOVIRUS REACTIVO IGM CITOMEGALOVIRUS REACTIVO GGT >400 IGG 2.395 CARGA VIRAL HEPATITIS B NEGATIVA ANAS 1/1280 PATRÓN MOTEADO MITOCONDRIALES NEGATIVO LEPTOSPIRA IGM NEGATIVO ANTIGENO E HEPATITIS B NEGATIVO, INMUNOGLOBULINA G TOTAL 2.39 **19/01/2026** TGO 74 TGP 193 PT 9.4 INR 0.861 PTT 29.9 BT 11.9 BD 8.1 BI 3.8 ALT 40.3 AST 32.6 FOSFATASA ALCALINA 1034.4. **21/02/2026** BT 13.6 BD 9.5 BI4.1, ALT 37.2 AST 29.3, FOSFATASA ALCALINA 1079.3 **22/02/2026** BT 13.2 BBD 9.9 BI 3.30 FOSFATASA ALCALINA 1046.1 **23/02/2026:** BT 12.9 BD 8.7 BI 4.20 **24/02/2026** BT 11.7, BD 7.7, BI 4. **25/02/2026** BT 9.6 BD 6.4 BI 3.20, ALT 50.9 AST 29.4.	**13/01/2026 COLANGIORESONANCIA** EL HÍGADO PRESENTA FORMA, TAMAÑO E INTENSIDAD DE SEÑAL NORMALES, SIN OBSERVAR LESIONES FOCALES. LAS ESTRUCTURAS VASCULARES TIENEN CURSO, CALIBRE Y AUSENCIA DE SEÑAL SATISFACTORIA. LA VÍA BILIAR INTRA Y EXTRAHEPÁTICA TIENE CALIBRE NORMAL. COLÉDOCO DE CURSO Y CALIBRE NORMAL SIN ALTERACIONES INTRALUMINALES NI ZONAS DE ESTENOSIS DIÁMETRO DE 5 MM. VESÍCULA BILIAR DE PAREDES DELGADAS Y CONTENIDO LÍQUIDO HOMOGÉNEO. **CONCLUSIÓN: COLELITIASIS, SIN COLECISTITIS.**

Diagnósticos

1. Hepatitis autoinmune colestásica
2. Síndrome biliar secundario
3. Infección por citomegalovirus
4. Infección por leptospira
5. Postoperatorio de colecistectomía por laparoscopia Dr Sánchez 20/01/2026

Plan de manejo médico

Manejo intrahospitalario	Manejo ambulario
➢ Hospitalizar Medicina Interna ➢ Dieta hipograsa ➢ Líquidos orales libres 2 litros dia ➢ Adapter ➢ Azatropina 50mg vo c 12h	➢ Azatioprina 50mg via oral cada 12h ➢ Doxiciclina 100mg vo cada 12h por 8 días ➢ Prednisona 50mg + prednisolona 20mg via oral dia (dosis total 70mg) disminuir 10 mg cada semana ➢ Acido ursodesoxicolico 300mg vía oral cada 8h

➢ Doxiciclina 100mg vo c 12h ➢ Prednisona 50mg vo dia - prednisolona 20mg vo dia (dosis total 70mg) ➢ Acido ursodeoxicolico 300mg vo c 8h ➢ Colestiramina 4g vo c 8h	➢ Colestiramina 4g via oral c 8h ➢ Control en 15 dias medicina interna ➢ Doppler portal ➢ Endoscopia de vías digestivas altas